

I. DATOS GENERALES

NOMBRE: SANTIAGO ANDRES MERIÑO SAUCEDO	H.C: 1066285985
EDAD: 15 años	FECHA DE NACIMIENTO: 21/10/2009
ESCOLARIDAD: 10 Grado	FECHA DE EVALUACIÓN: 22,23,28/05/2025 ENTREGA DE RESULTADOS: /05/2025
DIRECCION: Villa ligia 4 casa 6 - 15	CORREO: dunissaucedo23@hotmail.com
EPS: Particular	TELEFONO: 3176478258
ACOMPAÑANTE: Madre – Dunis Cecilia Saucedo	EVALUADOR: Jainer Guzmán Vega

II. MOTIVO DE CONSULTA:

Madre refiere “le han aplicado dos veces pruebas, queremos mirar el tema de la atención, a veces se le dificulta que se distrae”

III. ESTADO ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde los 7 años caracterizado por algunas quejas escolares por distraerse, levantarse del puesto, comenzó proceso de rehabilitación aproximadamente de 7 – 8 años con psicología, fonoaudiología (fonoaudiología refirió que todo estaba bien), se abordaba con la educadora especial tareas y temas relacionados de atención, actualmente presenta distractibilidad en materias que poco le motivan como lenguaje, filosofía, sociales, competencias, rendimiento básico en estas materias, hace tres años fue cambiado de institución educativa (antes estudiaba en Bosconia), el rendimiento académico era ajustado a las exigencias del plantel educativo. Le cuesta leer, le cuesta la comprensión lectora, debe leer varias veces para poder realizar las consignadas dadas en la lectura.

Estuvo medicado por psiquiatría infantil diagnosticado con trastorno mixto de ansiedad y depresión medicado con fluoxetina, sigue con la prescripción pero desde julio del 2024 no ingiere el medicamento.

Duerme a las 9 pm, se queda dormido a las 11 pm, en ocasiones se le restringe el celular, convive con la abuela, la madre labora en Bosconia, viene de forma frecuente a la ciudad los viernes, miércoles; madre lo describe como inmaduro, infantil.

Paciente refiere “En ocasiones siento que me estreso mucho (distrés), siento hipertensión en las venas, me palpan las venas, muchas veces me pasa que mis amigos están hablando, quiero aportar pero no puedo, me quedo en blanco y no puedo hablar, siento que no puedo decir nada, no tengo literalmente nada en la cabeza, no vocalizo bien, me frustro demasiado”.

No come guineo verde, le da asco el calle (guineo verde con queso), por lo generalmente es inapetente, está bajo de peso, presenta pubertad precoz.

A los 7 años varios compañeros le decían que hiciera cosas, que diera elementos, lo cual hacia para encajar en grupos sociales.

Mantiene una inadecuada posición sedente en silla, tiende a ser desordenado, tira las cosas, el cepillo de dientes lo tira, es un poco brusco, le cuesta terminar por ejemplo la rutina de cambiado cuando va al colegio, lo hace de forma desorganizada, tarda más de lo habitual en ejecutar las acciones o tareas.

IV. HISTORIA PERSONAL

PRENATALES: No embarazo previo, asistió a controles, embarazo sin riesgo, madre y padre no toman licor, no cigarrillo, no alucinógenos, adecuada alimentación, no auto medicación, no golpe abdominal o caída, alteraciones en estado de ánimo porque hermano falleció, lo que hizo que le subiera la presión (presión emotiva), naciendo de 37 semanas, no enfermedades médicas.

PERINATALES: Embarazo pretérmino de 37 semanas de gestación por cesárea, (no) utilización de fórceps, (no) maduración de pulmones en el útero, (no) hipoxia perinatal, no cianosis, (no) meconio, (no) sufrimiento fetal, (no) permaneció en incubadora.

V. DESARROLLO PSICOMOTOR

POSNATALES: Control cefálico 2 meses, rolado 3 meses, sentado 6 meses, gateo 8 meses- patrón recíproco, bipedestación 11 meses, marcha 12 meses, (si) reacción a los sonidos, (si) fijación de la mirada, lenguaje funcional, reporte peso al nacer 3000 kg, reporte de talla aproximado 59 cm.

VI. DESARROLLO DEL LENGUAJE

Balbuceo: 8 meses

Primeras palabras: 12 meses

Frases: 28 meses.

Oraciones: 30 meses.

VII. ABC

Come solo: desde los 24 meses.

Se baña solo: 6 años.

Se viste solo: 6 años.

Higiene personal: 7 años.

Control de esfínteres: 3 años diurno y nocturno.

VIII. ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción. No reporta

Epilepsia: No reporta

Autismo: No reporta

TDAH: No reporta

Esquizofrenia: No reporta

Tiroides: Madre y padre

IX. ANTECEDENTES PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: No reporta

Quirúrgicos: NO.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

X. HISTORIA DEL DESARROLLO

MOTOR: Normal.

LENGUAJE: Tendencia a la disfemia.

ADAPTATIVO: Anormal.

Comunicación, lenguaje y conversación concretos e inmaduros (si), Dificultad en la regulación de las emociones y el comportamiento (si), comprensión limitado del riesgo en situaciones sociales (si), juicio social inmaduro (si), es fácilmente manipulado por otros (si).
[6/6]

(No) Dependencia en las actividades de la vida diaria.

XI. HISTORIA ESCOLAR

Paciente quien cursara decimo grado, en el presente año en el primer trimestre perdió filosofía y sociales, con rendimiento básico actualmente en materias que no le motivan. Persisten dificultades para concentrarse, quiere ser sociable pero se le dificulta.

XII. HISTORIA SOCIOAFECTIVA

Inicia, mantiene y finaliza una interacción con otros. (si)

Reconoce sentimientos. (si)

Regular su propia conducta. (no)

Controla sus impulsos. (no)

Hace y mantiene relaciones de amistad y amor. (si)

Se comporta en público de manera socialmente aceptable. (si)

Termina las actividades que inicia. (si)

Acepta los límites del adulto. (algunas veces)

Cumple con normas de cortesía: por favor, gracias, permiso (si)

Resuelve problemas y situaciones cotidianas. (si)

Respeto los reglamentos deportivos y recreativos (si)

Realiza trabajos sin depender de otros. (si)

Se observan facies depresivas, en ocasiones se levanta si ganas de hacer nada, tendencia a la labilidad emocional, por momentos ansioso, le cuesta expresar sus ideas.

XIII. CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA CONSULTA

Paciente con adecuada presentación personal, inadecuada higiene postural, alerta, colaboradora, desorientado alo y orientada auto psíquicamente, algunos problemas en comprensión, baja tolerancia a la frustración, si, trastornos del lenguaje: dislalia leve, lenguaje fluido, no facilidad de contacto, juicio desviado, inteligencia aparentemente normal, pensamiento rígido.



ESCALA DE INTELIGENCIA
DE WECHLER PARA NIÑOS - V

Cuadernillo de anotación

Cálculo de la
edad
cronológica

Año Mes Día

Fecha de aplicación

2025 5 22

Fecha de nacimiento

2009 10 21

Edad Cronológica

15 7 1

Nombre del niño: SANTIAGO ANDRES MERIÑO SAUCEDO
Examinador: JAINER GUZMÁN VEGA

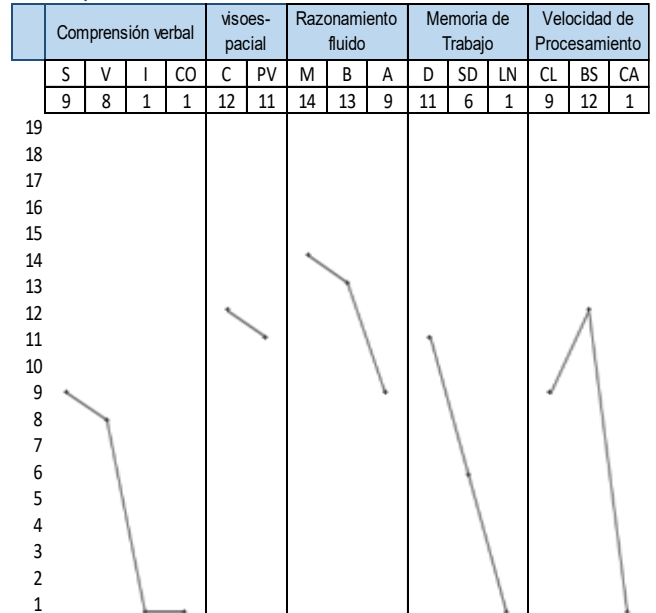
Página de resumen

Conversión de puntuaciones directas a puntuaciones escalares

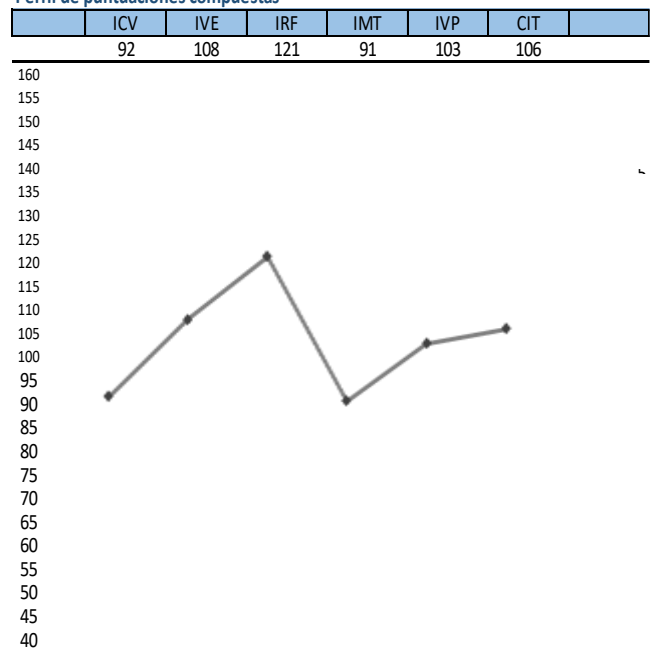
Prueba	PD	Puntuación escalar					
Cubos	42		12				12
Semejanzas	33	9					9
Matrices	26			14			14
Dígitos	31				11		11
Claves	63					9	9
Vocabulario	35	8					8
Balanzas	27			13			13
Puzles visuales	20		11				(11)
Spam de dibujos	22				6		(6)
Búsqueda de Símbolos	40					12	(12)
Información							(1)
Letras y números							(1)
Cancelación							(1)
Comprensión							(1)
Aritmética	22						(9)
Suma puntuaciones escalares		17	23	27	17	21	76

Comp. Verbal Visoes-pacial Razon. Fluído Mem. Trabajo Vel. Proces. Escala total

Perfil de puntuaciones escalares



Perfil de puntuaciones compuestas



Conversión de suma de puntuaciones escalares a puntuaciones compuestas

Escala	Suma punt. escalares	Puntuación compuesta	Rango Percentil	Intervalo de confianza 95%
Comprensión Verbal	17	ICV 92	30	84-102
Visoespacial	23	IVE 108	70	99-116
Razonamiento fluido	27	IRF 121	92	112-127
Memoria de trabajo	17	IMT 91	27	84-102
Velocidad de procesamiento	21	IVP 103	58	94-112
Escala total	76	CIT 106	66	99-112

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com

Análisis Primario						
Puntos fuertes y débiles						Punto fuerte o débil
		Puntuación	Puntuación de comparación	Diferencia	Valor crítico	
Índices	ICV	92	- 103	= -11	11,83	F o D
	IVE	108	- 103	= 5	9,81	F o D
	IRF	121	- 103	= 18	9,04	F o D
	IMT	91	- 103	= -12	8,64	F o D
	IVP	103	- 103	= 0	9,04	F o D
Pruebas	Semejanzas	9	- 10,5	= -1,5	3,28	F o D
	Vocabulario	8	- 10,5	= -2,5	3,57	F o D
	Cubos	12	- 10,5	= 1,5	3,15	F o D
	Puzles visuales	11	- 10,5	= 0,5	2,57	F o D
	Matrices	14	- 10,5	= 3,5	2,65	F o D
	Balanzas	13	- 10,5	= 2,5	2,46	F o D
	Dígitos	11	- 10,5	= 0,5	2,17	F o D
	Span de dibujos	6	- 10,5	= -4,5	2,46	F o D
	Claves	9	- 10,5	= -1,5	2,74	F o D
	Búsqueda de símbolos	12	- 10,5	= 1,5	2,65	F o D



Opciones de comparación de los índices			
Puntuación de comparación			
Suma de puntuaciones de los 5 índices primarios			
MIP	515	/ 5	103,0
Nivel de significación del valor crítico			

Opciones de comparación de las pruebas			
Puntuación de comparación			
Suma de puntuaciones escalares de las 10 pruebas principales			
MPE-P	105	/ 10	10,5

Comparación entre índices/pruebas					
Comparación	Puntuación 1	Puntuación 2	Diferencia	Valor crítico	Diferencia significativa
Índices	ICV-IVE	ICV 92 - IVE 108	= -16	12,54	S o N
	ICV-IRF	ICV 92 - IRF 121	= -29	12,05	S o N
	ICV-IMT	ICV 92 - IMT 91	= 1	11,80	S o N
	ICV-IVP	ICV 92 - IVP 103	= -11	12,50	S o N
	IVE-IRF	IVE 108 - IRF 121	= -13	10,43	S o N
	IVE-IMT	IVE 108 - IMT 91	= 17	10,14	S o N
	IVE-IVP	IVE 108 - IVP 103	= 5	10,43	S o N
	IRF-IMT	IRF 121 - IMT 91	= 30	9,53	S o N
	IRF-IVP	IRF 121 - IVP 103	= 18	9,83	S o N
	IMT-IVP	IMT 91 - IVP 103	= -12	9,53	S o N
Pruebas	Semejanzas-Vocabulario	S 9 - V 8	= 1	2,93	S o N
	Cubos-Puzles visuales	C 12 - PV 11	= 1	2,77	S o N
	Matrices-Balanzas	M 14 - B 13	= 1	2,29	S o N
	Dígitos-Span de dibujos	D 11 - SD 6	= 5	2,48	S o N
	Claves-Búsqueda de símbolos	CL 9 - BS 12	= -3	3,04	S o N

Opciones de comparación de los índices	
Nivel de significación del valor crítico	
Grupo de referencia	
Nivel de aptitud	

Opciones de comparación de las pruebas	
Nivel de significación del valor crítico	

ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA NIÑOS (WISC V)

Rango percentil	Clasificación
130	Muy superior
120 - 129	Superior
110 - 119	Promedio alto
90 - 109	Promedio
80 - 89	Promedio bajo
70 - 79	Inferior
55 - 69	Discapacidad leve
40 - 54	Discapacidad moderada

La Capacidad Intelectual Total (CIT), es un indicador de la relación entre los cuatro índices en los cuales se encuentran agrupadas las 10 subpruebas. El paciente obtuvo un CIT de **106**, lo que lo ubica en un rango dentro del promedio para su edad y nivel escolar.

Comprensión verbal

El valor obtenido en CV es de **92**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. Lo cual representa la capacidad para utilizar la información previamente aprendida, la experiencia educativa informal y formal, así como repertorios lingüísticos, manejo de analogías y análisis de relación.

Razonamiento visoespacial o perceptivo

El valor obtenido en RP es de **108**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de razonamiento perceptivo incluye el razonamiento espacial y la integración visomotora, procesos viso perceptuales y visos constructivos, así como razonamiento abstracto. De esta manera se identifican capacidades para analizar y sintetizar estímulos visuales, para categorizar, clasificar, dar juicios analógicos y razonamientos seriales dando cuenta de forma verbal.

Razonamiento fluido

El valor obtenido es de **121**, se clasifica con una capacidad general **superior**, ubicándose dos rangos por encima del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. Este índice mide la capacidad cognitiva innata del paciente para procesar nueva información.

Memoria de Trabajo

El valor obtenido en MT es de **91**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándolo dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de la memoria de trabajo (MT) es una medida de la memoria a corto plazo reflejando la capacidad para retener temporalmente en la memoria cierta información, trabajar con ella y generar resultados, implicando razonamiento, concentración, control mental.

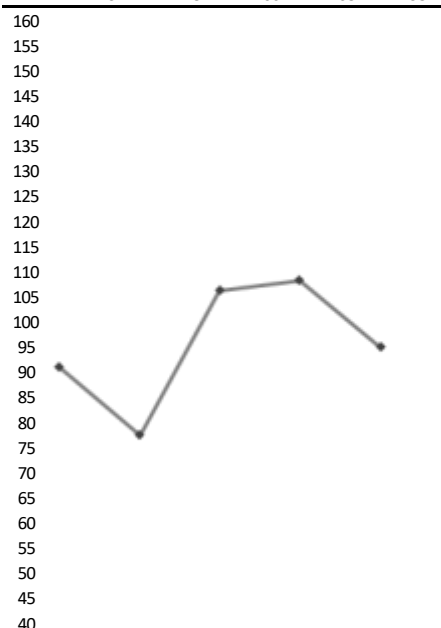
Velocidad de procesamiento

El valor obtenido en VP es de **103**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándolo dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. En esta prueba se mide la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para aparear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.

Análisis Secundario					
Suma de puntuaciones escalares					
Pruebas	Puntuación escalar				
Cubos			12	12	
Semejanzas				9	
Matrices			14	14	
Dígitos		11			11
Claves			9		9
Vocabulario				8	
Balanzas	13		13	13	
Puzles visuales			11		
Span de dibujos			6		6
Búsqueda de símbolos					12
Letras y números		1			
Aritmética	9				
Suma de puntuaciones escalares	22	12	65	56	38
	Raz. Cuantitativo	Mem. Trabajo auditivo	No verbal	Capacidad General	Competencia Cognitiva



IRC	IMTA	INV	ICG	ICC
91	78	106	108	95



Conversión de suma de puntuaciones escalares a índices					
Escala	Suma puntuaciones escalares	Índice		Rango Percentil	Intervalo de confianza 95%
Razonamiento Cuantitativo	17	IRC	91	27	84-99
Memoria de trabajo auditiva	12	IMTA	78	7	72-87
No verbal	65	INV	106	66	99-112
Capacidad general	56	ICG	108	70	101-114
Competencia cognitiva	38	ICC	95	39	89-104

En el análisis secundario se puede evidenciar que existe adecuado razonamiento cuantitativo, sin embargo la memoria de trabajo auditiva se encuentra con muy por de bajo del promedio, 78 inferior, dos rangos por debajo del promedio, en ocasiones pareciera que no escuchara, se debe repetir varias veces la consigna, por ejemplo en las tareas de memoria verbal del Neuropsi 3, las respuestas estuvieron por debajo del promedio acompañado de fuga de ideas, lo cual le puede generar dificultades en asignaturas específicas donde se requiere un alto grado de escucha, motivación, control atencional, manejo de información en línea y de forma simultánea.

**PERFIL NEUROPSI ATENCIÓN Y MEMORIA**

Nombre y apellido SANTIAGO ANDRES MERIÑO SAUCEDO
Fecha evaluación 5/05/2025
Fecha nacimiento 21/10/2009
Edad 15 años 7 meses
Grado escolar 10 grado
Baremos Baremos Edad: 14 a 15 años

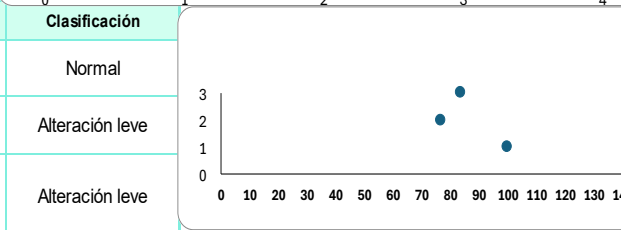
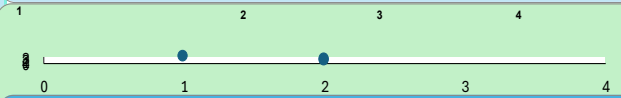
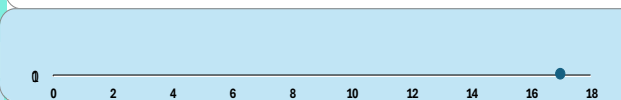
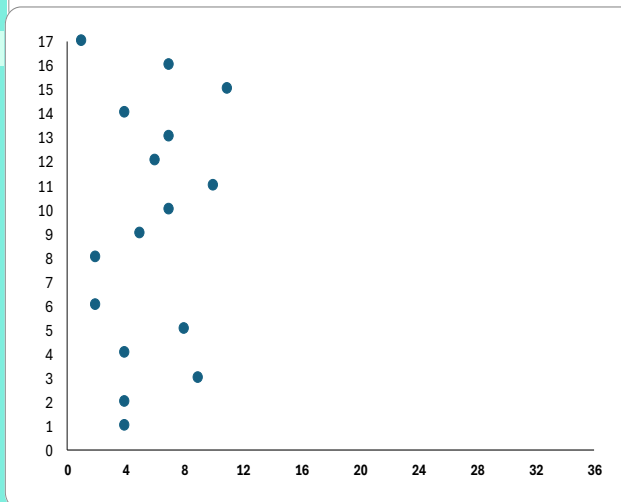
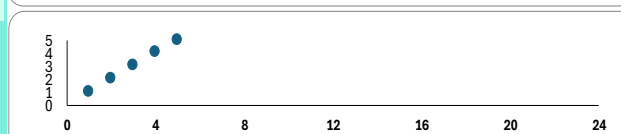
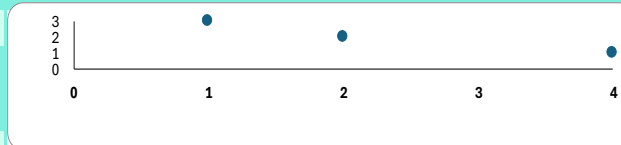
3ª edición

Neuropsi

Atención y Memoria

SubEscala y Puntuación Máxima**GRAFICO ASOCIADO A PUNTAJE NORMALIZADA**

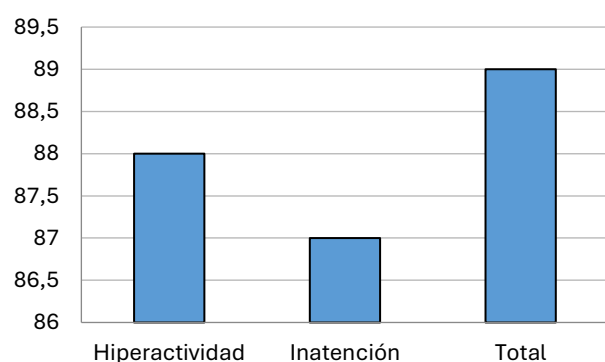
ORIENTACIÓN	Puntuacion Natural	Puntuacion Reclasificada	
Tiempo (4)	4		
Espacio	2		
Persona	1		
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN	Puntuacion Natural	Puntuacion Reclasificada	
Retención de dígitos en progresión	5		
Cubos en progresión	5		
Detección visual aciertos	24		
Detección dígitos total	20		
Series sucesivas	0		
MEMORIA	Puntuacion Natural	Puntuacion Reclasificada	
Trabajo. Retención de dígitos en regresión	4		
Trabajo. Cubos en regresión	4		
Codificación. Curva de memoria volumen promedio	9		
Codificación. Pares asociados volumen promedio	4		
Codificación. Memoria lógica promedio historias	8		
Codificación. Memoria lógica promedio temas	2		
Codificación. Figura Semicompleja / Rey-Osterreith	46		
Codificación. Caras	2		
Evocación. Memoria verbal espontánea	5		
Evocación. Memoria verbal por claves total	7		
Evocación. Memoria verbal reconocimiento total	10		
Evocación. Pares asociados total	6		
Evocación. Memoria lógica promedio historias	7		
Evocación. Memoria lógica promedio temas	4		
Evocación. Figura semicompleja / Rey-Osterreith	11		
Evocación. Nombres	7		
Evocación. Reconocimiento total de caras	1		
FUNCIONES EJECUTIVAS	Puntuacion Natural	Puntuacion Reclasificada	
Formación de categorías	17		
Fluidez verbal semántica (reclasificada)	15		2
Fluidez verbal fonológica (reclasificada)	8		2
Fluidez no verbal total (reclasificada)	5		1
Funciones motoras total	14		
Stroop puntuación interferencia (reclasificada)	32	1	
Stroop aciertos interferencia (reclasificada)	1	1	
PUNTUACIONES TOTALES	Puntuación Natural	Puntuación Normalizada	
Total atención y funciones ejecutivas	99	100	
Total memoria	137	77	
Total atención y memoria	236	84	



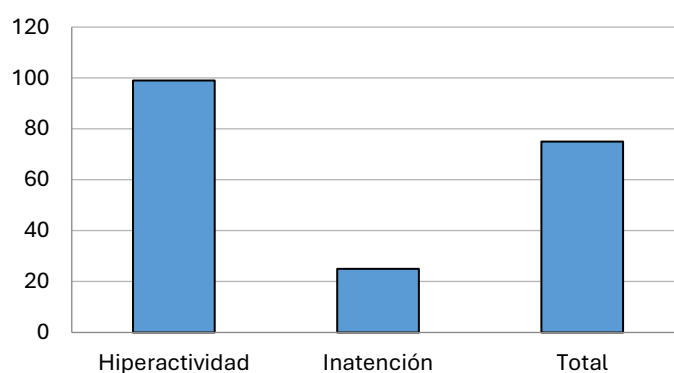
TDAH 5 HOGAR			
RESULTADOS DEL TDAH 5 HOGAR ADOLESCENTE			
ESCALA	PB	PERCENTIL	CLINICAMENTE
Hiperactividad	7	88	RIESGO
Inatención	13	87	RIESGO
Total	20	89	RIESGO
DETERIORO		PERCENTIL	CLINICAMENTE
Relaciones con los padres	0	60	NINGUNO
Relaciones con los pares	1	95	LEVE
Tareas	2	95	MODERADO
Desempeño Académico	2	95	MODERADO
Conducta	0	75	NINGUNO
Autoestima	2	99	MODERADO

TDAH 5 ESCUELA			
RESULTADOS DEL TDAH 5 ESCUELA ADOLESCENTE			
ESCALA	PB	PERCENTIL	CLINICAMENTE
Hiperactividad	18	99	SIGNIFICATIVO
Inatención	1	25	DESCARTAR
Total	19	75	DESCARTAR
DETERIORO	PB	PERCENTIL	CLINICAMENTE
Relaciones con el maestro	2	98	MODERADO
Relaciones con los pares	2	95	MODERADO
Tareas	2	90	MODERADO
Desempeño Académico	2	90	MODERADO
Conducta	2	95	MODERADO
Autoestima	2	50	MODERADO

TDAH 5 HOGAR ADOLESCENTE



TDAH 5 ESCUELA ADOLESCENTE



COMENTARIOS.

ORIENTACIÓN: Adecuada orientación auto y alopsíquica.

ATENCIÓN: Presenta un desempeño adecuado en la atención focalizada, sostenida, selectiva (distractivo), sin embargo necesita un alto grado de motivación para mantenerse en la actividad, puede perder el control atencional con facilidad, la efectividad de las tareas dependerá del grado del estímulo e interés del paciente, afectando la calidad de las respuestas.

MEMORIA: Presenta mayor desempeño en memoria visual a corto y largo plazo, con un menor desempeño de gravedad leve en la evocación de información de contenido auditivo verbal a corto y largo plazo, las respuestas no fueron consistentes en el desarrollo de las tareas, podía ejecutar tareas de memoria a corto plazo auditivo verbal de forma correcta y otras donde se requería un mayor alto grado de esfuerzo como pares asociados y memoria lógica las respuestas estuvieron por debajo del promedio.

LENGUAJE: El paciente presenta un adecuado desempeño en lenguaje expresivo, receptivo y expresivo, existe adecuada abstracción e información. sin embargo necesito apoyo para mejorar la precisión de las respuestas, en ocasiones se observo fuga de ideas – responde con un tema no relacionado, a pesar de tener adecuado lenguaje, la fluidez verbal fonológica esta afectada levemente, esto se puede deber a la baja interacción y socialización que tiene el menor, comenzando a mostrar algunas afectaciones que de no ser intervenidas pueden generar un cuadro mayor.

Se observaron problemas articulatorios, no problemas de nasalización, hipofonia, parafasias semánticas, fonológicas o visuales.

PRAXIAS VISO CONSTRUCCIONALES: Se identifica nivel normal para la edad y escolaridad en lo que se refiere a la copia de modelos a través del sistema grafo motor, coordinación viso motora y proceso viso perceptuales. No se observa dificultad en el proceso para el manejo de proporciones, detalles de la imagen, integración de los elementos, exactitud, sin omisión de los elementos.

GNOSIAS: No se observan alteraciones en el reconocimiento de la información previamente aprendida a través de nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto.

FUNCIONES EJECUTIVAS: A pesar de tener puntuaciones generales adecuadas en las funciones ejecutivas, en el desarrollo de algunas tareas como fluidez fonológica las respuestas estuvieron por debajo del promedio, le costó planificar, organizar y ejecutar comandos bajo una directriz, a pensar de alcanzar el objetivo, se observó baja tolerancia a la frustración, se debe fortalecer los procesos de seguimiento de instrucciones, atención para tareas complejas, control atencional, meta memoria, metacognición, automotivación y mantenimiento de la intensidad en tareas que no son de su agrado, mal manejo de las emociones ante la pérdida del control.

16 PF

Nombre:	SANTIAGO ANDRES		
Apellidos:	MERINO SAUCEDO		
Edad:	15	Sexo:	M
Cargo:	Estudiante	Fecha:	28 mayo 2025
	indices	PD	DE
	IM	4	1

Escalas Primarias		Notas		El polo bajo define una persona	Dekatipo										El polo alto define una persona
		PD	DE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	Afabilidad	8	3	Frio, impersonal, distante.			X								Cálido, afable, generoso, atenta a los demás.
B	Razonamiento	4	2	De pensamiento concreto.		X									De pensamiento abstracto.
C	Estabilidad emocional	8	2	Reactivo, emocionalmente cambiante.		X									Emocionalmente estable, adaptado, maduro.
E	Dominancia	2	1	Deferente, cooperador, que evita conflictos.	X										Dominante, segura de sí mismo, obstinado.
F	Animación	8	4	Serio, reprimido, cuidadoso.				X							Animoso, espontáneo, activo, entusiasta.
G	Atención a las normas	6	3	Inconformista, muy suyo, indulgente.			X								Atenta a las normas, cumplidor, formal.
H	Atrevimiento	4	3	Timido, temeroso, cohibido.			X								Emprendedor, atrevido y seguro en lo social.
I	Sensibilidad	4	4	Objetivo, nada sentimental, utilitario.				X							Sensible, idealista, sentimental, emotiva.
L	vigilancia	2	2	Confiado, sin sospechas, adaptable.		X									Vigilante, suspicaz, esceptica, precavida.
M	Abstracción	12	7	Practico, con los pies en la tierra, realista.							X				Abstraída, imaginativa, idealista.
N	Privacidad	6	4	Abierto, genuino, llana, natural.				X							Privada, calculadora, discreta que no se abre.
O	Aprensión	4	3	Apacible, buen nivel de autoestima, flexible.			X								Aprensiva, insegura, preocupada.
Q1	Apertura al cambio	12	2	Tradicional, conservador, resistente al cambio.		X									Abierta al cambio, experimental, analítica.
Q2	Autosuficiencia	4	4	Seguidor, se integra en el grupo.				X							Autosuficiente, individualista, solitaria.
Q3	perfeccionismo	6	3	Flexible, tolerante con el desorden o las faltas.			X								Perfeccionista, organizada, disciplinada.
Q4	tensión	6	5	Ausencia de tensión nervios, relajado, paciente.					X						Tensa, energica, impaciente, intranquila.

FACTORES GLOBALES															
EX	Extraversión		4,7	Introvertido, socialmente inhibido.				X							Extravertida, socialmente participadora.
AX	Ansiedad		4,6	Imperturbable, con ansiedad.				X							Perturbable, con mucha ansiedad.
TM	Dureza		8,1	Receptivo, de mente abierta, intuitiva.								X			Dura, firme, inflexible, fria, objetiva.
IN	Independencia		0,3	Acomodaticio, acepta acuerdos, cede facilmente.											Independiente, critica, polemiza, analítica.
SC	Autocontrol		3,3	No reprimida, sigue sus impulsos.			X								Autocontrolada, contiene sus impulsos.

Adaptación del test 16 PF 5 de R.B. Cattell

Nombre:	SANTIAGO ANDRES				
Apellidos:	MERINO SAUCEDO				
Edad:	15 Años	Sexo:	h		
Profesión:	Bachillerato	Fecha:	28 mayo 2025		
	índices	PD	DE	Percentil	
	IM	4	1	1	

Escalas Primarias		Notas		CUALIFICACIÓN
		PD	DE	
A	Afabilidad	8	2	0
B	Razonamiento	4	2	0
C	Estabilidad emocional	8	3	0
E	Dominancia	2	1	0
F	Animación	8	3	0
G	Atención a las normas	6	3	0
H	Atrevimiento	4	3	0
I	Sensibilidad	4	2	0
L	vigilancia	2	2	0
M	Abstracción	12	7	0
N	Privacidad	6	4	0
O	Aprensión	4	2	0
Q1	Apertura al cambio	12	2	0
Q2	Autosuficiencia	4	4	0
Q3	perfeccionismo	6	3	0
Q4	tensión	6	4	0

FACTORES GLOBALES				
EX	Extraversión		4,1	0
AX	Ansiedad		3,4	0
TM	Dureza		9,3	0
IN	Independencia		0,3	0
SC	Autocontrol		3,5	0

Adaptación del test 16 PF 5 de R.B. Cattell

COMENTARIOS 16 PF.

Se observo marcada dificultad para la estabilidad de las emociones, poco autocontrol, con tres desviaciones estándares, acompañado de rasgos depresivos y ansiosos, con mayor predominio ansioso, se muestra afable, pero distante, con alta necesidad de agradar, ser dominado, le cuesta adaptarse a los cambios sobre todo los que no son de su agrado, poca tendencia al perfeccionismo, con altos niveles de tensión y distrés a situaciones relacionadas con la interacción y temas académicos, se muestra receptivo pero con bajo nivel para seguir las instrucciones y normas, se denota alteraciones relacionadas con temas sensoriales o causadas por el ambiente, se muestra como un persona aprensiva, insegura y despreocupada, privado, calculador, le cuesta abrirse, abstraída, imaginativa en ocasiones muy idealista, vigilante, suspicaz, muy sensible y sentimental, muy competitiva con tendencia a agradar, inmaduro, con problemas de adaptación, reactivo y emocionalmente cambiante, pensamiento concreto, frio, impersonal, distante, confiado, sin sospecha, resistente al cambio, tolerante con el desorden y las faltas.



CONVERSIÓN DE LA PUNTUACIÓN TOTAL GLOBAL AL RANGO DE PREOCUPACIÓN DEL ADOS-2	
Rango de preocupación	Puntos de corte
Rango Cuantitativo	6
Rango Cualitativo	No TEA

**ADOS 2: ALGORITMO DIAGNÓSTICO: MODULO 3. FLUIDEZ VERBAL
NIÑOS Y ADOLESCENTES**

Afectación social (AS)

Comunicación

Narración de sucesos	(A-7)	1	1
Conversación	(A-8)	1	1
Gestos descriptivos, convencionales, instrumentales o informativos	(A-9)	0	0

Interacción social recíproca

Contacto visual inusual	(B-1)	2	0
Expresiones faciales dirigidas al examinador	(B-2)	0	0
Disfrute compartido durante la interacción	(B-4)	0	0
Características de las iniciaciones sociales	(B-7)	1	1
Calidad de respuesta social	(B-9)	1	1
Cantidad de comunicación social recíproca	(B-10)	0	0
Calidad general de la relación	(B-11)	1	1

TOTAL AS

5

Comportamiento restringido y repetitivo (CRR)

Comportamientos restringidos y repetitivos

Uso estereotipado o idiosincrásico de palabras o frases	(A-4)	0	0
Interés sensorial inusual en los materiales de juego o en las personas	(D-1)	1	1
Manierismo de manos y dedos y otros manierismos complejos	(D-2)	0	0
Intereses excesivo en temas u objetos inusuales o altamente específicos	(D-4)	0	0

TOTAL CRR

1

PUNTUACIÓN TOTAL GLOBAL (AS + CRR)

6

CODIFICACION ALGOTRIMO

TOTAL, AS	5
TOTAL, CRR	1
TOTAL, GLOBAL	6

Perfil del paciente:

Según la aplicación de las pruebas y observación clínica se obtiene un perfil de paciente con fenotipo no especificado, que debe ser revisado, por ejemplo el paciente no presenta problemas praxicos pero tiene una postura y marcha inusual, su facies denotan angustia y depresión, su comportamiento es bizarro o extraño a la interacción social prolongada, tendencia a la disfemia o tartamudez, por momentos presenta disprosodia, sin que exista riesgo considerable del espectro del autismo, existen rasgos de personalidad ansiosa o evasiva, elusiva, de pensamiento concreto, inhibido, le cuesta abrirse, problemas en la estabilidad de las emociones, cuestión que se debe intervenir ya que puede desencadenar en un cuadro mayor teniendo en cuenta que el cribado está en la adolescencia, etapa donde se desarrollan habilidades o afectaciones en la salud mental.

El paciente presenta una capacidad intelectual promedio, acompañada de perturbación de la actividad y la atención + hiperactividad o TDAH tipo combinado de gravedad moderada con afectación del comportamiento, haciendo la precisión de que en los resultado del TDAH 5 se obtuvieron puntuaciones de riesgo en los indicadores de inatención e hiperactividad en la lista de chequeo realizada por los padres, con riesgo alto en el indicador de hiperactividad sin riesgo en inatención por parte de los docentes, observándose en la evaluación conductas determinantes de manera específicas en el criterio de inatención.

Es importante dilucidar que las afectaciones en motivación y atención generan un impacto directo en el desempeño del aprendizaje en determinadas áreas en donde el esfuerzo debe ser prolongado y continuo, en ocasiones parece no escuchar, se debe repetir varias veces las instrucciones, olvida la consigna con facilidad, se angustia y se coloca ansioso, sobre todo si siente que no tiene el control de la situación, hasta lograr desestabilizarlo en caso de existir mucha presión externa; las fallas atencionales – distractibilidad se agudizan debido a que existe marcada afectación en la memoria de trabajo auditivo verbal con dos desviaciones estándares por debajo del promedio, por ejemplo las respuestas en cuanto al desarrollo del hemisferio cerebral derecho están por encima del izquierdo a pesar de que los dos están dentro del rango esperado por una diferencia de 16 puntos, se observó mayor desarrollo en tareas relacionadas con la memoria visual e inconsistente con la memoria auditivo verbal, necesitando un alto grado de motivación e instigación para obtener un buen desempeño en el desarrollo de las tareas, en caso de no tener esta motivación la efectividad en las tareas puede verse seria mente comprometida, se observó poco interés y preocupación por mantener un ritmo de aprendizaje, en ocasiones hace las cosas para salir de ellas, por cumplir, no se toma el adecuado tiempo para ejecutarlas, tiene una alta habilidad para responder con sus recursos innatos, sin embargo evita pensar, adoptando esta forma de pensamiento como un estilo de vida o modus vivendi reforzado de forma inadecuada por años a pesar de tener una inteligencia promedio; la velocidad de procesamiento o rapidez de ejecución de las tareas dependerá exclusivamente del paciente relacionado con la novedad del estímulo e intensidad, es posible que la desestabilización del estado de animo incida directamente sobre el desempeño académico, siendo necesario la estabilidad del estado de animo para mantener una adecuada cognición; las alteraciones en memoria de trabajo afectan la comprensión y los dispositivos de aprendizaje necesitando mas tiempo del habitual para aprender determinados conceptos de acuerdo al grado de complejidad de la lectura, agudizado por la tendencia la disfemia, generando frustración y problemas de autoestima con alta necesidad de intervención y seguimiento.

COMPRESIÓN VERBAL: PROMEDIO
VISOESPACIAL: PROMEDIO
RAZONAMIENTO FLUIDO: PROMEDIO
MEMORIA DE TRABAJO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: PROMEDIO

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

F412 RASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION.

F606 TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANSIOSA (EVASIVA, ELUSIVA) - estudio?

F900 *PERTURBACIÓN* DE LA ACTIVIDAD Y DE LA *ATENCIÓN* (TDAH tipo inatento y de gravedad moderada).

F985 TARTAMUDEZ [ESPASMOFEMIA] – estudio?

CIT DE 106, CAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL PROMEDIA.

PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta control por neuropsicología en tres meses.

Rehabilitación neuropsicológica 2 veces por semanas por dos meses para fortalecer los procesos cognitivos de atención sostenida, mantenimiento en la tarea, motivación, metacognición, memoria de trabajo, comprensión lectora, técnicas de memoria.

Rehabilitación dos veces por semana por psicología que permita abordar la interacción efectiva, manejo de la ansiedad y depresión, reconocimiento del tipo de personalidad, desarrollo de habilidades sociales, manejo de la frustración, flexibilidad, dejar de tener el control, dejar sentir las emociones y tramitarlas, autoafirmación, reconocer lo bueno y las cosas que debe mejorar, a partir de la inducción situacional después que se hayan desarrollado habilidades de manejo de conflictos evaluar proceso.

Seguir actividad física o musical que permita mejorar los procesos de biorritmo y habilidades sociales por lo menos tres veces por semana.

Realizar adecuación y adaptación curricular: Implementación del plan Individual de apoyos y ajustes razonables (PIAR) [Subsección 3 Esquema de atención educativa - Artículo 2.3.3.5.2.3.5], por parte de la institución educativa, que permita favorecer el proceso de avance del - la niña(o) en sus aprendizajes escolares, y fomentar la motivación hacia los mismos. Lo anterior implica ajustar los logros y competencias al nivel del - la niña(o), estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que curse y mecanismos que permitan potencializar los aprendizajes mediante diferentes estrategias de evaluación de contenidos y logros acordes a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente.

Dar un trato digno.

En caso de que no comprenda el texto, se recomienda hacer las actividades con compañero o con apoyo auditivo de la lectura para mayor comprensión.

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com

Realice seguimiento psicopedagogía para hacer una análisis cada tres meses de la conducta de la menor.

Psicoeduque a los demás estudiante para que integren al menor.

Realice ejercicios de compartir, del valor de la amistad, dar y recibir.

Fomente el aprendizaje colaborativo.

Fomente habilidades de confianza y liderazgo.

Tenga en cuenta que pueden existir algunos días desadaptativos en los cuales se debe brindar apoyo.

Tenga en cuenta que el menor se distrae con facilidad, tome lo con calma, anticipe lo que se hará en clase para que este preparado.

Haga una psicoeducación donde los demás estudiantes logren integrarlo de forma más efectiva.

Trate de comprender los días donde el comportamiento es mas desadaptativo.

Permítale recuperar los exámenes con talleres o repitiendo exámenes, sin dejar de exigirle, pero teniendo en cuenta sus limitaciones.

Trate de comprender el comportamiento, no se lo tome personal, está aprendiendo a regularse.

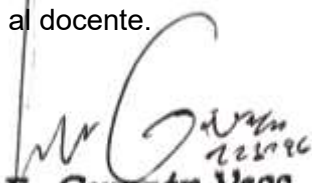
Utilice un lenguaje claro, mensaje corto y apoyo en lo visual y auditivo.

Coloque al lado del estudiante más sobresaliente para que modele las conductas positivas.

Dele un poco más de tiempo para las tareas.

Refuerce las conductas positivas.

Siente cerca al docente.



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096

Firma U.S.B. - Medellín

Nombre del Profesional: Jainer Enrique Guzmán Vega

Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad de San Buenaventura de Medellín.

No. Tarjeta Profesional:123096